

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	胃鏡 Panendoscopy				
	編號	制定者	公布日期	修正日期	檢閱日期
	A31000-Q04-W-A22	MI 賴美玉	88 年 12 月 31 日	108 年 11 月 18 日	114 年 12 月 04 日
	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	
版本/總頁數	第 3.5 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	

一、目的

讓護理人員了解食道之檢查目的、檢查前中後之準備、禁忌症及注意事項，以提昇護理品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）檢查目的

- 1.檢查食道、胃及十二指腸有無不正常、潰瘍、出血，並可立即進行止血、電燒等。
- 2.檢查有無不正常之病兆如腫瘤，進行取下組織病理學檢查或細胞學檢查協助診斷。
- 3.決定合適的治療方法。
- 4.應用於治療。

（二）檢查前準備

- 1.醫師向病人解釋檢查的目的、過程、方法及注意事項。
- 2.打電話至檢查室，安排檢查時間。
- 3.開立檢查電腦單
- 4.
- 5.。
- 6.填寫檢查同意書。

主題名稱	胃鏡	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A22	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	2/6

- 7.檢查前1-2天，不可施行胃部X光檢查及腸胃道攝影術，因攝影檢查之鋇劑會妨礙胃內觀察。
- 8.檢查前一天晚餐，採流質飲食。
- 9.午夜後禁止進食及服藥（需禁食8小時），含煙、酒、咖啡、茶等刺激性東西。
- 10.請病人取下活動假牙。
- 11.指導病人在檢查中的配合事項：用鼻子吸氣嘴巴吐氣。
- 12.給予心理支持。
- 13.依醫囑檢查前30分給予口服Gascon Syrup約4-5 cc，以防止胃粘液附著於胃鏡的鏡面及減少胃液內氣泡形成。
- 14.送檢前核對執行。

（三）檢查中護理

- 1.依醫囑檢查前 10 分鐘 Gascon Syrup 約 5-10 cc 給病人喝下、Buscopan 1Amp 肌肉注射及 10% Xylocaine 噴劑予喉嚨麻醉（含住 1-2 分鐘，勿吐出）。須注意病人是否對某些藥物過敏，或心肺臟有問題，以免檢查過程出意外，如：青光眼、心臟病或前列腺肥大症者要預先告訴醫生，以衡量要不要使用 Buscopan。
- 2.先換上寬鬆衣物，協助採左側臥姿於檢查台上，頭部往前傾勿後仰雙腿微曲。
- 3.防咬器置病人口中，若無法配合之病人則協助固定之。
- 4.胃鏡經喉嚨時請病人配合吞嚥動作，當過了喉嚨則改請病人鼻子吸氣嘴巴吐氣，此時應全身放鬆、稍做吞嚥動作，使胃鏡順利通過喉嚨進入食道。
- 5.醫師在做診斷時，不要做吞嚥動作，而應改由鼻子吸氣，口中緩緩吐氣，檢查中保持鼻子正常呼吸，切勿憋氣，並讓口水自然流出，不要吞下以免噎到，以便檢查順利完成。有時會因空氣隨管子進入胃中，而感覺脹氣、噁心。如感覺疼痛不適，請向醫護人員打個手勢，勿抓住管子或發出聲音。
- 6.檢查一般約花 10-15 分鐘，依檢查目的不同而時間有差異。
- 7.依病人情況隨時監測生命徵象。

主題名稱	胃鏡	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A22	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	3/6

8.隨時觀察病人有無不適。

(四) 檢查後護理

- 1.檢查後極少發生口乾、視力模糊、心悸、小便困難等暫時現象，如有腹痛、嘔吐、吐血、頭昏、心跳或呼吸困難等上述症狀發生時，請即刻告知醫護人員。
- 2.檢查後 1 至 2 小時內暫不進食，必須等吞嚥反射、作嘔反射恢復，若喉嚨沒有感覺不舒服，可先喝一口開水看喉頭反射是否恢復；若無噎到，就可先進食軟性食物，以免粗糙食物造成食道或胃出血若有作切片檢查應兩小時後再進食。有些人會有短暫的喉嚨痛、異物感，通常 1 至 2 天就可恢復。
- 3.若喉嚨痛厲害，予口腔護理，可用溫水或生理食鹽水漱口。

(五) 禁忌症

- 1.特別緊張者。
- 2.不合作的病人。
- 3.COPD 急性期如氣喘發作時。
- 4.食道腫瘤壓迫貴門者。
- 5.精神病人。
- 6.急性心肌梗塞一週內。
- 7.疑似腸胃道穿孔者。
- 8.任何原因引發休克狀況者。

(六) 注意事項

若有疑問或檢查後不適感，可隨時請教或通知醫護人員。

(七) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

主題名稱	胃鏡	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A22	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	4/6

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	胃鏡	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A22	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
88.12.31	1.0	新制定。	88 年 12 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.10.31	2.1	1. 檢查前準備 7.新增：含煙、酒、咖啡、茶等刺激性東西。 2. 檢查中護理刪除：5.會注射肌肉鎮靜劑，使胃部停止蠕動，達到影像清晰的目的（若有青光眼、心臟病或前列腺肥大症者要預先告訴醫生，以衡量要不要用此鎮靜劑）。	101 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.21	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.10.31	3.1	1. 檢查前準備 5 新增:檢查前 1-2 天禁腸胃道攝影術，因攝影檢查之銀劑會妨礙胃內觀察。 2. 檢查後 1.新增:極少發生口乾、視力模糊、心悸、小便困難、吐血、頭昏、心跳或呼吸困難等上述症狀發生時需告知醫護人員。	103 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
104.10.31	3.2	1. 第三項第(一)、(二)目部份內容刪修。 2. 第三項第(四)目之 2 新增待必須等吞嚥反射、作嘔反射恢復才可開始進食。	104 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
105.10.31	3.3	第三項第(三)目之 5 內容增修。	105 年 10 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
106.10.31	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.11.14	3.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第二目之 12 刪除：於電腦申請單上蓋「已執行」印章。	107 年 11 月 14 日護理長會議通過。

主題名稱	胃鏡	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q04-W-A22	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	6/6

修正日期	版本	修正說明	備註
108.11.18	3.5	1. 第三項第一、五目文字修訂。 2. 第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 11 月 13 日 護理長會議通過； 108 年 11 月 18 日 督導會議通過公布。
109.12.03	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.12.02	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.12.08	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.12.07	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.05	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.12.04	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	